туберкульоз легень дітей та підлітків наявне достовірне збільшення в сироватці крові СРБ, Нр, ЦП, Тф. При цьому не залежно від резистентності збудника МБТ, вміст □гострофазних□білків в крові перевищував довірчий інтервал норми: Нр у 81,2 % дітей і в 79,6 % підлітків, Тф - 76,3 % і 77,6 %, ЦП - 65,7 % і 76,4 %, СРБ – 6□,□□ і 76,2 %, відповідно. Інтенсивність підвищення рівня □гострофазних□білків у сироватці крові дітей та підлітків хворих на туберкульоз органів дихання залежала від активності, фази, поширеності (розповсюдженості) процесу і вірогідно збільшувалась, відносно величин норми, при активному перебігу захворювання, розвитку поширених і деструктивних змін в легеневій тканині. Зростання величин показників білків □гострої фази□в обох вікових групах було достовірно вищим при хіміорезистентному туберкульозі. Позитивний кореляційний зв'язок з високим та середнім коефіцієнтом кореляції встановлено між рівнем Нр (□= 0,78), Тф (□= 0,74), ЦП (□ = 0,67) СРБ (□= 0,63) та клінічною вираженістю специфічного процесу, гостротою і розповсюдженістю туберкульозних змін. В обох групах, як у дітей та підлітків, не залежно від типу збудника (чутливості/резистентності) зростання значень (частота та інтенсивність змін рівня) "гострофазних" білків залежала від фази специфічного процесу і було достовірно вищим при наявності деструктивних змін в легеневій тканині.

У хворих на туберкульоз дітей та підлітків, до початку АМБТ, констатували зміни функціонального стану печінки, які характеризувалися зростанням в 1,3-1,4 рази активності трансаміназ. Зростання показників АЛТ та АСТ можуть бути обумовлені, як посиленням процесів трансамінування амінокислот у печінці, так і пошкодженням гепатоцитів внаслідок наявної туберкульозної інтоксикації.

188. ЕФЕКТИВНІСТЬ АНТИБІОТИКОТЕРАПІЇ НЕГОСПІТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ

Бенца Т.М., Денова Л.Д.
м.Київ, Україна, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Мета: оптимальний вибір антибактеріального препарату для лікування негоспітальної пневмонії (НП) у хворих на цукровий діабет (ЦД) 2 типу.

Матеріали і методи: протягом 7 місяців нами було обстежено та проліковано 86 хворих з НП та супутнім ЦД 2 типу віком від 39 до 72 років. З урахуванням клінічної характеристики всі хворі віднесені до другої групи НП. Відмінностей за демографічними показниками не було. Всіх хворих розподілили на 2 групи. В 1-й групі (44 хворих) було призначено перорально моксифлоксацин по 0,4 г 1 р/д протягом 7 діб. В 2-й групі (42 хворих) отримували перорально амоксицилін/клавунат по 875/125 мг 2 р/д та азитроміцин по 0,5 г 1 р/д протягом 7 діб. Крім того, хворі приймали муколітики (амброксол, бромгексин, ацетилцистеїн), проводилась медикаментозна терапія супутнього захворювання за загальноприйнятими протоколами.

Результати та обговорення: клінічне покращання (нормалізація температури тіла, зменшення проявів інтоксикації та дихальної недостатності) на 7-й день лікування зафіксовано у 40 хворих (90,9%) 1 групи, та у 38 хворих (90,4%) 2 групи. Контрольний огляд на 21 день після лікування засвідчив клінічне одужання у 1-й групі – 42 хворих (95,5%), в 2-й групі – 40 хворих (95,2%). Частота побічних ефектів (діарея, нудота, головний біль) відзначалась у 20 хворих (47,7%) у 1-й групі та 23 хворих (54,8%) у 2-й групі. Найчастіше спостерігалась діарея – у 5 хворих (25%) у 1-й групі та 7 хворих (30,4%) у 2-й групі.

Висновок: моксифлоксацин ефективніший та безпечніший у лікуванні хворих на НП другої групи з супутнім ЦД 2 типу.

189. ДИНАМІКА КЛІНІКО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ ПІД ВПЛИВОМ АЛЕРГЕН-СПЕЦИФІЧНОЇ ІМУНОТЕРАПІЇ

Беш О.М., Радченко О.М., Бандрівська А.З., Мазур М.В.
м.Львів, Україна
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Актуальність. Бронхіальна астма (БА) залишається актуальною проблемою медицини, оскільки контролювати хворобу і сьогодні далеко не завжди вдається. Така ситуація значною мірою пояснюється тим, що для переважної більшості хворих не використовуються всі існуючі терапевтичні можливості. Зокрема, це стосується і недостатнього призначення алерген-специфічної імунотерапії (АСІТ), яка дозволяє не лише зменшити чутливість організму до "винного" алергену, але й знизити активність хронічного запалення.

Мета дослідження: аналіз динаміки клініко-функціональних показників у хворих на БА під впливом АСІТ.

Об□єкт дослідження. Для проведення дослідження сформовано дві групи, які були ідентичні за віком □□□-50 років), статтю, важкістю захворювання, однаковими вихідними показниками спірометрії та астма-контроль тесту. В основну групу увійшли 45 пацієнтів, які поєднували базисне медикаментозне лікування (інгаляційні глюкокортикостероїди (ІГКС) або комбінацію ІГКС та β_2-агоністів пролонгованої дії або